

TEMA 7.9 • NEFROLOGÍA

Hiperparatiroidismo Secundario a la Insuficiencia Renal Crónica

PERFIL EUNACOM 1.06.1.010
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

IRC — Etapas, Complicaciones y Terapia de Reemplazo Renal

Estadios de IRC (por Clearance de Creatinina)

TABLA 7.9.1: ETAPA VS CLEARANCE CR (ML/MIN)		
ETAPA	CLEARANCE CR (ML/MIN)	HALLAZGO
1	> 90	Creatinina normal + daño renal (microalbuminuria, etc.)
2	60–90	Leve
3	30–60	Aparecen: Anemia + Osteodistrofia renal
4	15–30	Aparecen: Hiperkalemia + Acidosis . Preparar fístula AV
5	< 15	Inicio de diálisis (indicación habitual)

> Diálisis se inicia con CrCl < 15 + **síntomas** (lo más frecuente). Si asintomático, puede esperarse hasta < 5.

Tratamiento General de IRC

Frenar Progresión

TABLA 7.9.2: MEDIDA VS DETALLE	
MEDIDA	DETALLE
Tratar la causa	DM, HTA controladas
Evitar nefrotóxicos	AINES contraindicados, ajustar dosis de fármacos excretados renalmente
IECA / ARA-II (yeka/sartán)	Reducen proteinuria y frenan progresión

Contraindicaciones de IECA/ARA-II en IRC: - K⁺ > 6 mEq/L (hiperkalemia severa) - Clearance < 30 mL/min

Manejo de Complicaciones

TABLA 7.9.3: COMPLICACIÓN VS TRATAMIENTO	
COMPLICACIÓN	TRATAMIENTO
Anemia	Fierro EV + Eritropoyetina (EPO) hasta Hcto > 30%
Hiperparatiroidismo 2°	Vitamina D + Quelantes de fósforo (calcio o sevelamer) + dieta baja en P
Acidosis	Bicarbonato de sodio VO o EV
Hipervolemia / EPA	Restricción hidrosalina + Furosemida ± vasodilatadores
Hiponatremia	Restricción de agua libre
Hiperkalemia leve	Dieta baja en K ⁺ + resinas de intercambio
Hiperkalemia grave	Gluconato de calcio (estabiliza membrana) + Insulina + Salbutamol + Diálisis

Terapia de Reemplazo Renal

TABLA 7.9.4: MODALIDAD VS FRECUENCIA			
MODALIDAD	FRECUENCIA	VENTAJA	DESVENTAJA
Hemodiálisis	3 veces/semana	Más disponible, gratuita en Chile	Menor calidad de vida
Diálisis Peritoneal	Todas las noches (en casa)	Mejor calidad de vida	Más cara, requiere aprendizaje
Trasplante Renal	Definitivo	Mejor calidad de vida	Necesita donante compatible, riesgo de rechazo

Rechazo de Trasplante

TABLA 7.9.5: TIPO VS TIEMPO		
TIPO	TIEMPO	CLÍNICA
Hiperagudo	Horas	SIRS + falla renal fulminante
Agudo	< 3 meses	IRA
Crónico	> 3 meses	IRC progresiva

- Todos tratan con inmunosupresores + corticoides.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Paciente con IRC etapa 3 presenta calcio de 8.0 mg/dL, fósforo de 5.8 mg/dL y PTH de 180 pg/mL (elevada). ¿Cuál es el diagnóstico?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Hiperparatiroidismo Secundario a la Insuficiencia Renal Crónica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Transcripción con error técnico - contenido reconstituido del contexto de otras clases.
- Hiperparatiroidismo secundario aparece desde etapa 3 de IRC (clearance bajo 60).
- Fisiopatología: retención de fósforo → quela calcio → hipocalcemia → PTH sube.
- IRC además reduce producción de vitamina D activa (calcitriol) en el riñón.
- Laboratorio: PTH alta, calcio bajo o normal, fósforo alto.
- Tratamiento: vitamina D + dieta baja en fósforo + quelantes de fósforo (carbonato de calcio) + calcio.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO A LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA)**PREGUNTA 1**

Paciente con IRC etapa 3 presenta calcio de 8.0 mg/dL, fósforo de 5.8 mg/dL y PTH de 180 pg/mL (elevada). ¿Cuál es el diagnóstico?

- ☐ A) Hiperparatiroidismo primario
- ☐ B) Hiperparatiroidismo secundario a IRC
- ☐ C) Hipoparatiroidismo
- ☐ D) Hipercalcemia maligna
- ☐ E) Déficit de vitamina D dietario simple

PREGUNTA 2

¿Cuál es el tratamiento fundamental del hiperparatiroidismo secundario a IRC?

- ☐ A) Paratiroidectomía
- ☐ B) Vitamina D activa + quelantes de fósforo + calcio
- ☐ C) Bifosfonatos endovenosos
- ☐ D) Solo restricción de fósforo en la dieta
- ☐ E) IECA para protección renal

PREGUNTA 3

¿A partir de qué etapa de la IRC aparecen las alteraciones del metabolismo calcio-fósforo?

- ☐ A) Etapa 1
- ☐ B) Etapa 2
- ☐ C) Etapa 3
- ☐ D) Etapa 4
- ☐ E) Etapa 5

RESUMEN: HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO A LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

Nota: La transcripción de esta clase presenta un error técnico (audio no capturado correctamente). El contenido esperado cubre la osteodistrofia renal y el hiperparatiroidismo secundario como complicación de la IRC, que aparece desde la etapa 3. La fisiopatología inicia con retención de fósforo por la caída de la filtración glomerular. El fósforo elevado quela el calcio produciendo hipocalcemia, lo que estimula la secreción de PTH (hiperparatiroidismo secundario). Además, la IRC reduce la producción de vitamina D activa (calcitriol), contribuyendo a la hipocalcemia. El tratamiento consiste en vitamina D activa (calcitriol), dieta baja en fósforo, quelantes de fósforo (carbonato de calcio) y suplementos de calcio. El objetivo es normalizar el calcio, bajar el fósforo y controlar la PTH.